*▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir.
Beşeri tıbbi ürünün adı: ULTOMİRİS® (Ravulizumab) 300 mg/3 mL infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre **Kantitatif bileşimi ve ambalaj içeriği:** İnfüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre içeren 3 ml'lik her bir flakon 300 mg ravulizumab içerir (100 mg/ml). **Endikasyonları:** Erişkinlerde ve çocuklarda paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH) ve atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS) tedavisinde endikedir. Yüksek hastalık aktivitesine işaret eden klinik semptomu/semptomları olan hemolizli veya en az son 6 aydır eculizumab ile tedavi edildikten sonra klinik olarak stabil olan PNH hastalarında endikedir. Vücut ağırlığı 10 kg veya üzerinde olan, daha önce kompleman inhibitörü tedavisi görmemiş veya en az 3 aydır eculizumab almakta olan ve eculizumaba yanıt verdiğine dair kanıtı olan yetişkin ve pediyatrik aHÜS hastalarının tedavisinde endikedir.Erişkinlerde anti-asetilkolin reseptör (AChR) antikoru pozitif yetişkin Jeneralize Miyastenia Gravis (jMG) hastalarının tedavisi için standart tedaviye ek tedavi olarak ve relaps eğilimi gösteren, anti-akuaporin-4 (AQP4) antikoru pozitif olan hastalarda nöromiyelitis optika spektrum bozukluğunda (NMOSB) endikedir. **Pozoloji ve uygulama şekli:** *Yetişkin PNH, aHÜS, jMG veya NMOSB hastaları:* Önerilen doz uygulama rejimi, intravenöz infüzyonla uygulanan bir yükleme dozunu takiben idame dozunu içerir. Uygulanacak dozlar, hastanın vücut ağırlığına göre ayarlanır. Yetişkin hastalarda (≥18 yaş), idame dozları, yükleme dozunun uygulanmasından 2 hafta sonra başlanarak 8 haftada bir uygulanmalıdır. Doz uygulama programının zaman zaman planlanan infüzyon gününden ± 7 gün değişmesine izin verilir (ULTOMİRİS®'in ilk idame dozu hariç), ancak sonraki doz orijinal programa göre uygulanmalıdır. Vücut ağırlığı ≥40 ila <60 olan hastada yükleme dozu: 2.400 mg, İdame dozu: 3.000 mg, Doz aralığı: 8 haftada bir. Vücut ağırlığı ≥60 ila <100 olan hastada yükleme dozu: 2.700 mg, İdame dozu: 3.300 mg, Doz aralığı: 8 haftada bir. Vücut ağırlığı ≥100 olan hastada yükleme dozu: 3.000 mg, İdame dozu: 3.600 mg, Doz aralığı: 8 haftada bir. Daha önce kompleman inhibitörü tedavisi görmemiş veya eculizumab ya da ravulizumab enjeksiyonluk çözeltiden tedavi geçişi yapan hastalarda tedaviye başlama talimatları: Popülasyon: Halihazırda ravulizumab veya eculizumab ile tedavi edilmiyor, Ağırlığa dayalı ravulizumab intravenöz yükleme dozu: Tedavi başlangıcında, İlk ağırlığa dayalı ravulizumab intravenöz idame dozunun zamanı: Ravulizumab intravenöz yükleme dozundan 2 hafta sonra; Popülasyon: Halihazırda eculizumab ile tedavi ediliyor, Ağırlığa dayalı ravulizumab intravenöz yükleme dozu: Planlanan bir sonraki eculizumab dozu zamanında, İlk ağırlığa dayalı ravulizumab intravenöz idame dozunun zamanı: Ravulizumab intravenöz yükleme dozundan 2 hafta sonra. *Pediyatrik PNH veya aHÜS hastaları:* Vücut ağırlığı ≥ 40 kg olan pediyatrik hastalar, Bu hastalar yetişkinlerin doz önerilerine göre tedavi edilmelidir. Vücut ağırlığı ≥10 ila <20 olan pediyatrik hastada yükleme dozu: 600 mg, İdame dozu: 600 mg, Doz aralığı: 4 haftada bir. Vücut ağırlığı ≥20 ila <30 olan pediyatrik hastada yükleme dozu: 900 mg, İdame dozu: 2.100 mg, Doz aralığı: 8 haftada bir. Vücut ağırlığı ≥30 ila <40 olan pediyatrik hastada yükleme dozu: 1.200 mg, İdame dozu: 2.700 mg, Doz aralığı: 8 haftada bir. Eculizumabdan ravulizumaba geçiş yapan hastalar için, ravulizumabın yükleme dozu, son eculizumab infüzyonundan 2 hafta sonra uygulanmalı ve ardından, yükleme dozu uygulamasından 2 hafta sonra başlayarak, yukarıda belirtildiği gibi ağırlığa dayalı dozlama rejimine göre idame dozları uygulanmalıdır. ULTOMİRİS®, vücut ağırlığı 30 kg'ın altında olan pediyatrik PNH pediyatrik hastalarında çalışılmamıştır. Bu hastalar için önerilen pozoloji, ULTOMİRİS® ile tedavi edilen aHÜS ve PNH hastalarında mevcut olan farmakokinetik/farmakodinamik (FK/FD) verileri temelde pediyatrik aHÜS hastalarında kullanılan pozolojiye dayanmaktadır. PNH kronik bir hastalıktır ve klinik durum ravulizumabın kesilmesini gerektirmedikçe, ravulizumab tedavisine hastanın yaşamı boyunca devam edilmesi önerilir. aHÜS'te, trombotik mikroanjiyopati (TMA) belirtilerini gidermek için ULTOMİRİS® tedavisi, en az 6 ay olmalı, bunun yanında tedavi süresi, her hasta için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Tedavi eden sağlık mesleği mensubu tarafından (veya klinik olarak endike) TMA nüksü açısından daha yüksek risk altında olduğu belirlenen hastalar, kronik tedavi gerektirebilir. Yetişkin jMG veya NMOSB hastalarında, ULTOMİRİS® tedavisi sadece kronik uygulama aşamasında çalışılmıştır. Sadece intravenöz infüzyon içindir. Bu tıbbi ürün 0,2 µm'lik bir filtreden geçirilerek uygulanmalıdır ve intravenöz puşe veya bolus enjeksiyon olarak uygulanmamalıdır. ULTOMİRİS® infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre 3 mL'lik flakonlarda (100 mg/mL) sunulmaktadır ve 50 mg/mL'lik nihai bir konsantrasyona seyreltilmelidir. Seyreltmeyi takiben, vücut ağırlığına bağlı olarak enjektör tipi bir pompa veya bir infüzyon pompası kullanılarak intravenöz infüzyonla en az 0,17 ila 1,3 saat (10 ila 75 dakika) arasında uygulanmalıdır. **Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Karaciğer Yetmezliği:** Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ULTOMİRİS®'in güvenliliği ve etkililiği incelenmemiştir; bununla birlikte farmakokinetik veriler, karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerektirmediğini ortaya koymaktadır. **Böbrek Yetmezliği:** Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. **Pediyatrik popülasyon:** Vücut ağırlığı 10 kg'ın altında olan PNH veya aHÜS'lü çocuklarda ULTOMİRİS®'in güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. jMG veya NMOSB'li çocuklarda ULTOMİRİS®'in güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. Veri bulunmamaktadır. **Geriyatrik popülasyon:** 65 yaş ve üzeri PNH, aHÜS, jMG veya NMOSB hastaları için herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. Yaşlı kişiler tedavi edilirken özel bir önlemin gerekli olduğuna işaret eden herhangi bir kanıt mevcut olmamasına karşın klinik çalışmalarda yaşlı

PNH, aHÜS veya NMOSB hastalarından ULTOMİRİS® ile elde edilen deneyim sınırlıdır.. **Kontrendikasyonlar:** Ravulizumab ya da diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Tedavi başlangıcında iyileşmemiş *Neisseria meningitidis* enfeksiyonu olan hastalarda, aşılama sonrasında 2 haftaya kadar uygun antibiyotiklerle profilaktik tedavi almamış ve hali hazırda *Neisseria meningitidis*'e karşı aşılanmamış hastalarda ULTOMİRİS® tedavisi başlatılmamalıdır. **Özel kullanım uyarıları ve önlemleri:** *Ciddi meningokokkal enfeksiyon:* Etki mekanizması nedeniyle, ULTOMİRİS® kullanımı hastanın meningokokkal enfeksiyona/sepsise (*Neisseria meningitidis*) duyarlılığını artırır. Herhangi bir serogrubun yol açtığı meningokokkal hastalık meydana gelebilir. Bu enfeksiyon riskini azaltmak için, ULTOMİRİS® tedavisini geciktirme riski meningokokkal enfeksiyon geliştirme riskinden daha ağır basmıyorsa, tüm hastalar ULTOMİRİS® tedavisine başlamadan en az iki hafta önce meningokokkal enfeksiyonlara karşı aşılanmalıdır. Meningokok aşısını aldıktan sonra 2 haftadan daha kısa bir süre içinde ULTOMİRİS® tedavisine başlayan hastalar, aşılamadan 2 hafta sonrasına kadar uygun profilaktik antibiyotiklerle tedavi görmelidir. Yaygın patojenik meningokok serogruplarının önlenmesinde mümkün olan yerlerde A, C, Y, W135 ve B serogruplarına karşı aşılama tavsiye edilir. Hastalar, aşı kullanımına ilişkin mevcut ulusal kılavuzlara göre aşılanmalı veya aşılar tekrarlanmalıdır. Hasta eculizumab tedavisinden geçiş yapıyorsa, doktorlar, ulusal aşı kullanımına ilişkin kılavuzlara göre meningokok aşısının güncel olduğunu doğrulamalıdır. Meningokokkal enfeksiyonu önlemek için aşılama yeterli olmayabilir. Antibakteriyel ajanların uygun kullanımına ilişkin resmi kılavuzlar dikkate alınmalıdır. ULTOMİRİS® ile tedavi edilen hastalarda ve diğer terminal kompleman inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda ciddi veya ölümcül meningokokkal enfeksiyonlar/sepsis vakaları bildirilmiştir. Tüm hastalar meningokokkal enfeksiyon ve sepsisin erken belirtileri açısından izlenmeli, enfeksiyondan şüpheleniliyorsa hemen değerlendirilmeli ve uygun antibiyotiklerle tedavi edilmelidir. *İmmünizasyon:* ULTOMİRİS® tedavisine başlamadan önce, hastaların güncel immünizasyon kılavuzlarına göre immünizasyonun başlatılması önerilmektedir. Aşılama, komplemanı daha da aktifleştirebilir. Sonuç olarak, kompleman aracılı hastalıkları olan hastalar, altta yatan hastalıklarının bulgu ve belirtilerinde artış yaşayabilirler. Bu nedenle, önerilen aşılamadan sonra hastalar hastalık belirtileri açısından yakından izlenmelidir. 18 yaşından küçük hastalar *Haemophilus influenzae* ve pnömokok enfeksiyonlarına karşı aşılanmalıdırlar ve her bir yaş grubu için ulusal aşı önerilerine kesinlikle uyulması gerekmektedir. *Diğer sistemik enfeksiyonlar:* ULTOMİRİS® tedavisi, aktif sistemik enfeksiyonu olan hastalara dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. ULTOMİRİS® terminal kompleman aktivasyonunu bloke eder; bu nedenle hastaların *Neisseria* türleri ve kapsüllü bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı duyarlılığı artmış olabilir. Yaygın gonokokkal enfeksiyonları dahil *Neisseria* türleri (*Neisseria meningitidis* dışında) ile ciddi enfeksiyonlar bildirilmiştir. Hekimler gonoreden korunma konusunda hastalara bilgi vermelidir. *İnfüzyonla ilişkili reaksiyonları:* ULTOMİRİS® uygulaması infüzyonla ilişkili sistemik reaksiyonlara ve alerjik veya aşırı duyarlılık reaksiyonlarına, anafilaksi dahil, neden olabilir. Klinik çalışmalarda infüzyon reaksiyonları yaygın olarak görülmüştür. Hafif ila orta şiddette ve geçici olarak sırt ağrısı, karın ağrısı, kas spazmları, kan basıncında düşüş, kan basıncında yükselme, kasılmalar, uzuvlarda rahatsızlık, ilaca aşırı duyarlılık (alerjik reaksiyon), tat alma duyusunda bozukluk (kötü tat) ve uyuşukluk yan etkileri yer almaktadır. İnfüzyonla ilişkili sistemik reaksiyon durumunda, kardiyovasküler instabilite veya solunum sıkıntısı belirtileri ortaya çıkarsa ULTOMİRİS® uygulaması durdurulmalı ve uygun destekleyici önlemler alınmalıdır. *Eculizumabdan ravulizumaba geçiş:* Onaylı eculizumab doz rejimine yanıt vermeyen jMG hastalarında, ULTOMİRİS® tavsiye edilmez. *Yardımcı maddeler:* Bu tıbbi ürün, sodyum klorür 9 mg/mL (%0,9) enjeksiyonluk çözelti ile seyreltildikten sonra, bu tıbbi ürün, en yüksek dozda 72 mL başına 180 mg sodyum içermekte olup bu değer, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir yetişkin için önerilen günlük en yüksek 2 g sodyum alımının %9,1'ine eşdeğerdir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. **Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri:** ULTOMİRİS® ile herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır. ULTOMİRİS®'in, rituksimabın komplemena bağımlı sitotoksisitesi üzerindeki potansiyel inhibitör etkisine dayanarak, ravulizumab, rituksimabın beklenen farmakodinamik etkilerini azaltabilir.**Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):** Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi sırasında ve tedaviden sonraki 8. aya kadar etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır. **Gebelik dönemi:** Gebelik kategorisi C'dir. ULTOMİRİS®'in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin klinik veri bulunmamaktadır. ULTOMİRİS®'in, gebe kadınlarda, riskler ve faydalar değerlendirildikten sonra kullanımı düşünülmelidir. **Laktasyon dönemi:** ULTOMİRİS®'in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bebekler için risk göz ardı edilemez. Birçok tıbbi ürün ve immünoglobulin insan sütüne salgılandığından ve emzirilen bebeklerde ciddi advers reaksiyon potansiyeli olduğundan, ULTOMİRİS® tedavisi sırasında ve tedaviden sonraki 8. aya kadar emzirme kesilmelidir. **Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler:** Etkisi bulunmamaktadır ya da göz ardı edilebilir etkisi bulunmaktadır. **İstenmeyen etkiler:** ULTOMİRİS® (intravenöz formülasyon) ile en yaygın advers reaksiyonları baş ağrısı (%26,6), nazofarenjit (%17,5), üst solunum yolu enfeksiyonu (%16,8), diyare (%14,2), ateş (%12,2), bulantı (%12,2), artralji (%11,3), yorgunluk (%11,2), sırt ağrısı (%10,4) ve karın ağrısı (%10,1)'dır. En ciddi advers reaksiyonlar meningokokkal sepsisi içeren meningokokkal enfeksiyon (%0,6) ve meningokokkal ensefalittir. Her bir sıklık grubunda advers reaksiyonlar, azalan ciddiyet sırasına göre detaylı

olarak KÜB'de sunulmaktadır. **Doz aşımı:** Doz aşımı yaşayan hastalarda, infüzyon hemen kesilmeli ve herhangi bir advers reaksiyon işareti veya semptomu açısından yakından izlenmeli ve uygun semptomatik tedavi başlatılmalıdır. **Raf ömrü:** 18 ay. Seyreltildikten sonra, tıbbi ürün hemen kullanılmalıdır. Bununla birlikte kimyasal ve fiziksel olarak 2°C - 8°C'de 24 saate ve oda sıcaklığında 4 saate kadar stabil kaldığı gösterilmiştir. **Saklamaya yönelik özel tedbirler:** 2ºC - 8ºC arasında buzdolabında saklayınız. Dondurmayınız. Çalkalamayınız. Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız**. Ruhsat sahibi:** Alexion İlaç Ticaret Ltd. Şti. İçerenköy Mahallesi Umut Sk. Quick Tower Sit. No: 10-12/73 Ataşehir/İstanbul Tel: + (90) 216 251 70 00 Faks: + (90) 216 251 70 99 **Ruhsat Tarihi ve Numarası:** 04.07.2025 - 2025/292 **Güncel KÜB onay tarihi:** 04.07.2025 **KÜB özeti onay tarihi:** 01.04.2026 **Versiyonu**: **4.0**. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır. ULTOMİRİS® Risk Yönetim programı ve kontrollü dağıtım kapsamında kısıtlanmış reçete ile satılır. 19.12.2025 tarihi itibariyle Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil): ULTOMİRİS® (Ravulizumab) 300 mg/3 mL infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre 187.206,30 TL.

* Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezine (TÜFAM) bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).